

Ucieczka *od samoświadomości*

Heatherton & Baumeister 1991: *epizod nie jest o jedzeniu — jest o ucieczce od bolesnej samoświadomości. Mechanizm cognitive narrowing. 80% epizodów poprzedza negatywny afekt (Hilbert 2013 EMA).*

CZAS: 30 min · psychoedukacja · Etap 3 CBT-E (sesje 12–18) · po stabilizacji

ŹRÓDŁO: Heatherton & Baumeister (1991, *Psychol Bull*); Hilbert i in. (2013)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **teorię ucieczki** + *cognitive narrowing* (sekcja 1), **typowe emocje wyzwalające** (sekcja 2). Sekcja 3 — mapa wyzwalczy. Sekcja 4 — strategie regulacji.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Teoria ucieczki (*escape theory*, Heatherton & Baumeister 1991, *Psychological Bulletin*): epizod jedzeniowy jako **ucieczka od bolesnej samoświadomości**. Mechanizm: bolesne porównanie z ideałem → wysoka negatywna samoświadomość → *cognitive narrowing* → epizod daje **chwilową ulgę**. *Epizod nie jest o jedzeniu — jest o uniknięciu emocji*. Hilbert i in. (2013, EMA): **80% epizodów** poprzedza *negatywny afekt*. Po epizodzie afekt *wzrasta* — cykl. Polivy & Herman (1985, *masking hypothesis*). Konsekwencja kliniczna: praca z cyklem bulimii **wymaga** pracy z regulacją emocji — sama stabilizacja jedzenia nie wystarczy.

01 ● Mechanizm *cognitive narrowing*

Faza 1: Negatywna emocja o sobie (wstyd, samokrytyka, porównanie z ideałem) → **Faza 2:** Wysoka samoświadomość: „*jestem za gruba, nieudana*” → **Faza 3:** *Cognitive narrowing* — zawężenie uwagi do „*tu i teraz*”, do prostych bodźców → **Faza 4:** Jedzenie jako *fokus uwagi* — odwraca od myśli o sobie → **Faza 5:** Epizod + krótka ulga → wstyd po → wzmocnienie negatywnych emocji → *cykl*.

Klucz: jedzenie w epizodzie *nie* jest „*chęcią jedzenia*” — jest **narzędziem ucieczki** przed myślami o sobie. Smak, tekstura, intensywność doznań *zalewają* umysł, nie pozostawiając miejsca na bolesną samoświadomość. To *chemiczna* dystrakcja. Ulgą jest krótka — wstyd po epizodzie wraca, często silniejszy.

02 = Typowe emocje wyzwalające epizod

WSTYD, SAMOKRYTYKA

„*Jestem za słaba, niewystarczająca*”. Często po porównaniu z innymi (społecznie, w mediach), po krytyce.

SAMOTNOŚĆ, PUSTKA

Wieczór sam/sama w mieszkaniu, weekend bez planów, niedzielne wieczory. Klasyczne konteksty epizodów.

ZŁOŚĆ, FRUSTRACJA

Po konflikcie, niesprawiedliwym zdarzeniu, niemożności wyrażenia złości w sytuacji. Jedzenie jako wyładowanie.

SMUTEK, ŻAL

Po stracie, rozstaniu, zawodzie. Jedzenie jako „*pocieszenie*” — chwilowe ukojenie, ale wzmacnia smutek.

NIEPOKÓJ, LĘK

Przed wystąpieniem, egzaminem, spotkaniem. Jedzenie jako redukcja aktywacji fizjologicznej

NUDA, BRAK STYMULACJI

Stan „*pustki dnia*”, brak zainteresowań, monotonia. Jedzenie jako wypełnienie czasu

03 \ Moja mapa emocjonalnych wyzwalaczy

Rozpoznaj swoje **typowe emocje** poprzedzające epizody. Zapisz konkretne sytuacje — to *wzorzec*, który można potem adresować. Bez świadomości wyzwalaczy nie da się ich obejść.

EMOCJA POPRZEDZAJĄCA	SYTUACJA, W KTÓREJ SIĘ POJAWIA	CO ZWYKLE ROBIĘ

04 Alternatywne strategie regulacji emocji

NAZWIJ EMOCJĘ

Sam akt nazwania emocji obniża jej intensywność (Lieberman 2007 — *affect labeling*). „Czuję wstyd. To jest wstyd.”

KONTAKT Z DRUGĄ OSOBĄ

SMS, telefon, krótkie spotkanie. Obecność innej osoby *przerywa* cognitive narrowing skuteczniej niż samotne dystrakcje.

EKSPRESJA W PISANIU

Dziennik emocji, list nienadany, opis sytuacji. Pisanie *wyprowadza* emocje z ciała w zewnętrzną formę.

RUCH FIZYCZNY ŁAGODNY

Spacer, łagodna joga, stretching. Aktywność łagodzi aktywację bez bycia kompensacją. **Nie** intensywne ćwiczenia.

Klucz: teoria ucieczki Heathertona & Baumeistera (1991) zrewolucjonizowała rozumienie bulimii. *Przed* jej publikacją epizody traktowano głównie jako problem *jedzenia*. *Po* — jako problem *regulacji emocji*. To paradygmatyczna zmiana. Hilbert i in. (2013) potwierdzili empirycznie: 80% epizodów poprzedza negatywny afekt — to nie przypadek, to *funkcja*. Bulimia jako *strategia regulacji emocji* (Wonderlich i in. 2010) — niedoskonała, krótkotrwała, kosztowna, ale *działająca* w chwili. Konsekwencja kliniczna: *nie można* zredukować epizodów bez jednoczesnej pracy z regulacją emocji. Jeśli pacjent dostaje narzędzia jedzeniowe (3+2, dziennik, regularne posiłki), ale emocje pozostają niewspierane, *znajdzie* nowe strategie ucieczki — nadużywanie substancji, samouszkodzanie, izolację. Dlatego CBT-E w etapie 3 obejmuje *specjalny moduł* pracy z emocjami (Fairburn 2008), a DBT-BN (Safer, Telch & Chen 2009) buduje cały program wokół tego założenia. **Pierwszy krok:** świadomość, że epizody są *regulacją*, nie „brakiem dyscypliny”. To zmienia rozumienie siebie — z „jestem słaba” na „moje narzędzia są niedoskonałe, można je zmienić”.